
REPUBLIQUE ALGERRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE

Module d'Hépto-gastroentérologie

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

LES HEPATITES CHRONIQUES

Dr M.BOUMENDJEL

Maitre assistant

Service Hépto-gastroentérologie

CHU Constantine

PLAN

I-INTRODUCTION :

II-ANAPATH:

- 1- **A l'état normal (Rappel histologique du foie)**
- 2- **Au cours des hépatites chroniques :**
 - a- **Lésions élémentaires**
 - b- **Lésions d'orientation étiologique :**
 - c- **Classification**

III-: ETUDE CLINIQUE ET PARA CLINIQUE

- 1- **Clinique**
- 2- **Biologie**
- 3- **Morphologie**
- 4- **Histologie**
- 5- **Evaluation non invasive de la fibrose**
- 6- **Evolution**

IV- DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- 1- **Les hépatites virales**
- 2- **Les hépatites médicamenteuses**
- 3- **Les hépatites auto-immunes**
- 4- **La maladie de Wilson**

V- CONCLUSION

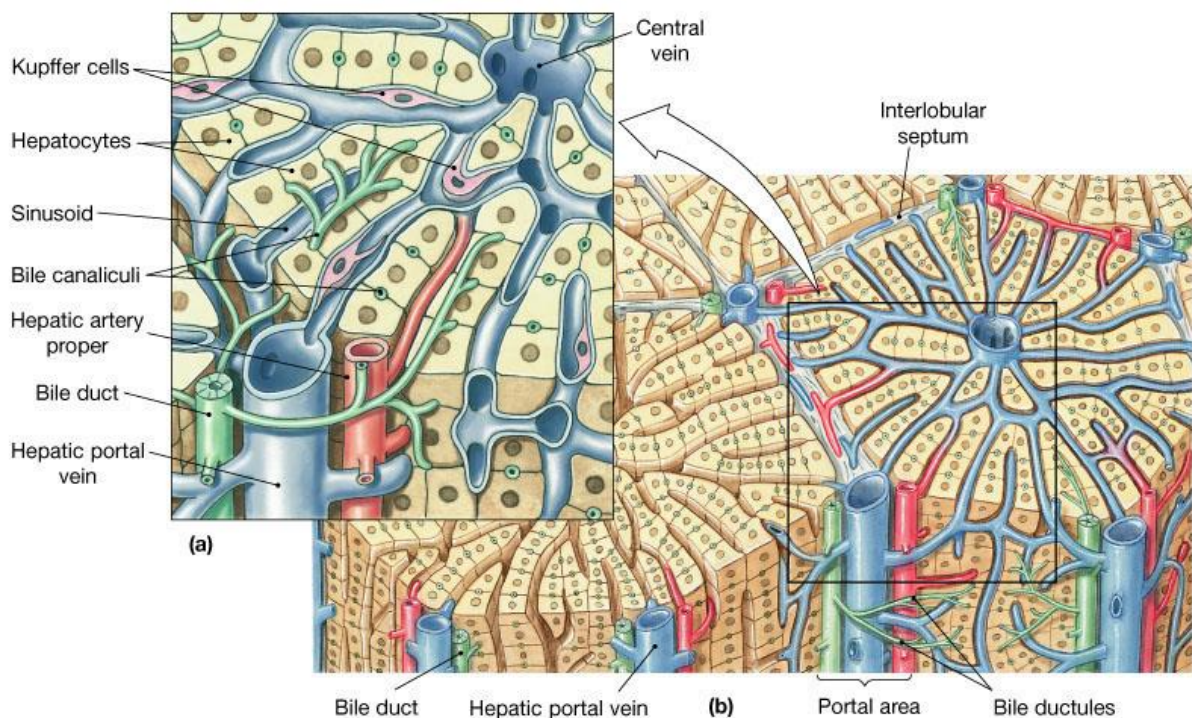
I-INTRODUCTION :

- ❖ La définition de l'hépatite chronique est histologique = Lésion hépatique nécrotique et inflammatoire persistante et progressive d'évolution chronique (**plus que 6 mois**) susceptible de conduire à la fibrose et à la cirrhose
- ❖ Le terme de chronicité englobe :
 - **Activité clinique** : durée d'évolution des symptômes supérieure à 6 mois (en particulier l'ictère).
 - **Activité biologique** : perturbation prolongée du bilan hépatique : cytolysé (augmentation des ALAT)
 - **Activité histologique** : intensité de la nécrose hépatocytaire et de l'infiltration inflammatoire

II-ANAPATH:

1- A l'état normal (Rappel histologique du foie) :

- Le parenchyme hépatique normal présente une structure lobulaire
- Le **lobule hépatique** est l'unité architecturale : il est centré par une **veine centro-lobulaire** (VCL) et limité en périphérie par les **espaces portes** (EP).
- Dans les lobules, les hépatocytes s'organisent en **travées** composées d'une rangée cellulaire séparée par des **sinusoïdes**.
- Chaque espace porte comprend une ou plusieurs sections de :
 - /canal biliaire
 - /veine porte
 - /artère hépatique



2- Au cours des hépatites chroniques :

a- Lésions élémentaires : (03 lésions élémentaires)

/L'Infiltration inflammatoire :

- Faite essentiellement de cellules mononuclées (lymphocytes et plasmocytes)
- Elle prédomine dans l'espace porte et la région péri portale

/La nécrose hépatocytaire :

- Nécrose **Focale** : nécrose en foyers péri lobulaire
- Nécrose **Parcellaire (Piecemeal necrosis)** : nécrose péri portale au contact de l'espace porte détruisant la lame bordante
- Nécrose **En pont (Bridging necrosis)** : nécrose pénètre dans le lobule intéressant les travées hépatocytaires et formant alors des ponts entre les espaces portes et la veine centrolobulaire

/La fibrose : elle désigne l'augmentation de la quantité du tissu conjonctif hépatique, elle débute dans la région portale puis sera étendue dans le lobule hépatique et on distingue :

- Fibrose **Portale** : épaissement et élargissement fibreux des espaces portes
- Fibrose **Péri portale** : expansion fibreuse irradiant à partir des espaces portes
- Fibrose **En pont** (fibrose septale) : fibrose extensive réunissant les structures vasculaires

b- Lésions d'orientation étiologique :

/Hépatite B :

- Hépatocytes en verre dépoli : présence dans le cytoplasme hépatocytaire de l'AgHbs
- Noyaux sableux : présence intra nucléaire de l'AgHbc

/Hépatite C :

- Infiltrat inflammatoire portal
- Lésions des canaux biliaires
- Stéatose macrovésiculaire

/Hépatite médicamenteuse :

- Infiltrat inflammatoire à polynucléaire éosinophile
- présence de petits granulomes
- Lésions des petits canaux biliaires

/Hépatite auto-immune :

- Infiltrat inflammatoire riche en plasmocytes
- Hépatocytes disposés en rosette

/Maladie de Wilson : Dépôts intra hépatocytaire de cuivre

c- **Classification : Score de Métavir**

L'évaluation des lésions histologiques tiens compte de deux grands critères :

1. **L'activité** (intensité de l'inflammation et de la nécrose)
2. **L'évolutivité** (la fibrose)

	Activité	Fibrose
0	absente	Absente
1	Minime	Portale
2	Modérée	Portale + quelques Septas
3	Sévère	Septale sans cirrhose
4		Cirrhose

III-: ETUDE CLINIQUE ET PARA CLINIQUE1- **Clinique** : spectre varié :

- Asymptomatique :
- Parfois des symptômes : douleurs, asthénie, ictère, prurit, HPM, SPM

2- **Biologie** :

Exploration fonctionnelle hépatique presque constamment anormale :

- Transaminases : 2 – 10 fois la normale, rarement plus avec souvent ALAT>ASAT.
- Phosphatases alcalines, Bilirubine, GGT, gamma globulines : normaux ou modérément élevés.
- TP, facteur V et Albuminémie : le plus souvent normaux mais peuvent diminuer en cas d'insuffisance hépato cellulaire
- Bilan à visée étiologique : sérologie virale B et C, bilan d'auto-immunité, bilan du cuivre,...

3- **Morphologie** :

- Echographie abdomino-pelvienne** : souvent normale mais peut parfois retrouver une HPM ou des signes d'HTP
- Fibroscopie digestive haute** : peut parfois retrouver des signes endoscopiques d'HTP (varices œsophagiennes, varices sous cardiales, gastropathie hypertensive)

4- **Histologie** :

La ponction biopsie du foie (**PBF**) représente l'examen de choix pour le diagnostic car c'est l'examen histologique qui va permettre le diagnostic en montrant les lésions élémentaires

5- **Evaluation non invasive de la fibrose**

Ces méthodes constituent une alternative pour l'estimation de la fibrose hépatique, mais elles restent peu fiables comparativement à la PBF qui reste l'examen de référence. Plusieurs de ces méthodes existent dont les plus connus sont :

- Le Fibrotest : combine plusieurs variables biologiques
- Le Fibromètre
- L'APRI : ASAT.Plaquettes.Ratio.Index
- Le Fibroscan : élastométrie impulsionnelle ultrasonore

6- Evolution :

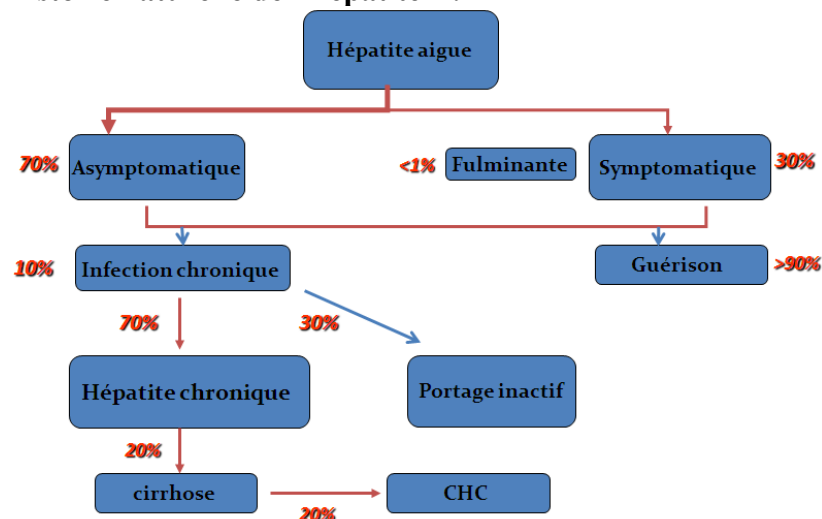
- Risque d'évolution vers la cirrhose et vers le carcinome hépato cellulaire (CHC).
- Le risque et la vitesse de constitution d'une cirrhose dépendent de :
 - /La cause de l'hépatite chronique
 - /Les comorbidités : intoxication alcoolique, syndrome métabolique...etc

IV- DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE :**1- Les hépatites virales****a- Hépatite chronique virale B :**➤ **Epidémiologie :**

- Problème de santé publique majeur, plus de 2000 millions ont été au contact du virus, 350 millions de porteurs chroniques.
- Transmission du virus : le VHB existe principalement dans le sang, le sperme et les sécrétions vaginales, il peut donc être transmis par voie parentérale (transfusion sanguine avant les mesures préventives, usage de matériel souillé, usage de drogues IV chez les toxicomanes), par voie sexuelle (rapports sexuels non protégés), ou par voie verticale (périnatale)
- Temps d'incubation est de 40-120 jours

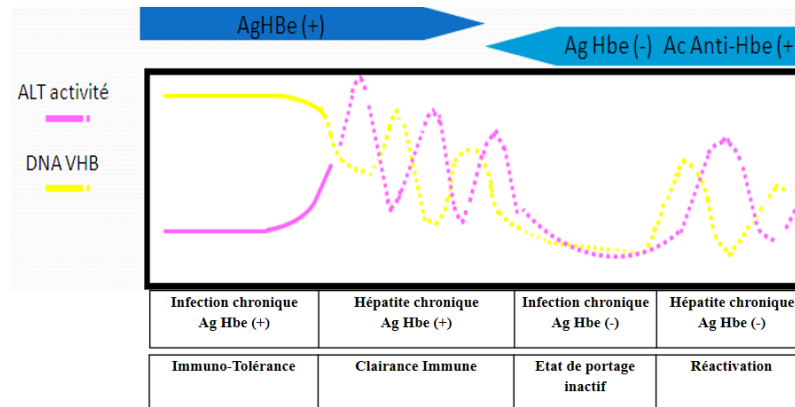
➤ **Virologie :**

- Le VHB est un virus à ADN double brin appartenant à la famille des Hepadnavirus
- Les marqueurs du diagnostic virologiques :
 - /Ag Hbs : marqueur d'infection (on parle d'hépatite chronique B si persistance de l'Ag Hbs au-delà de 6mois)
 - /Ac anti Hbs : marqueur de guérison (immunité définitive)
 - /Ag Hbc : retrouvé dans les hépatocytes mais ne circule pas dans le sang et donc ne peut pas être détecté
 - /Ac Hbc : marqueur de stigmata d'infection (récente «de type IgM » / ancienne « de type IgG »)
 - /Ag Hbe : marqueur de répllication virale
 - /Ac Hbe : marqueur de non répllication virale
 - /DNA viral : marqueur de répllication virale (détecté par PCR)

➤ **Histoire naturelle de l'hépatite B:**

➤ **Histoire naturelle de l'hépatite chronique B : 12**

- Infection chronique Ag Hbe (+) (Phase d'immunotolérance) :
Ag Hbs (+) Ag Hbe (+) charge virale ($> 10^7$ UI/mL) ALAT (normal)
- Hépatite chronique Ag Hbe (+) (Phase de clairance immune) :
Ag Hbs (+) Ag Hbe (+) charge virale ($10^4 - 10^7$ UI/mL) ALAT (élevé)
- Infection chronique Ag Hbe (-) (Phase de portage inactif) :
Ag Hbs (+) Ag Hbe (-) charge virale (< 2000 UI/mL) ALAT (normal)
- Hépatite chronique Ag Hbe (-) (Phase de réactivation) :
Ag Hbs (+) Ag Hbe (-) charge virale (> 2000 UI/mL) ALAT (élevé)

➤ **Diagnostic :**

- Souvent un diagnostic fortuit à l'occasion d'un dépistage systématique chez les donneurs de sang et chez des populations à risque (toxicomanie IV, patients transfusés, hémodialysée, homosexuels,...etc)
- Parfois un symptôme révélateur imposant la réalisation d'une sérologie virale : asthénie persistante, ictère, HPM, un syndrome d'HTP, ou une complication révélatrice (ascite, hémorragie digestive, CHC)
- Biologie : Ag Hbs (+) plus de 6 mois, taux d'ALAT parfois élevé
- Biologie moléculaire : quantification du DNA viral par PCR
- PBF : mise en évidence des lésions histologique spécifique et évaluation de la sévérité » de l'atteinte selon le Métavir

➤ **Traitement :**

- Indiqué si score de Métavir $\geq$ A2 et/ou F2
- But : stopper la réplication virale, stopper l'évolution vers la cirrhose et prévenir les complications
- Moyens thérapeutiques : interféron pégylé ou bien les antiviraux (Lamivudine, Ténofovir, Entécavir)

➤ **Prévention :**

- Vaccination
- immunoprophylaxie par les gamma globulines si : inoculation accidentelle, accouchement de Nouveau né (mère Hbs+), relation sexuelle non protégée.

b- Hépatite chronique virale D :

- Virus à ARN simple brin, c'est un virus déficient qui nécessite la présence du VHB pour pouvoir se multiplier
- Contamination selon deux modes :

- /Co-infection VHD-VHB : Ac anti D (+) /Ac anti Hbc type IgM (+)
- /Surinfection aigue : Ac anti D (+) /Ac anti Hbc type IgM (-)
- La vaccination contre le VHB protège contre le VHD

c- **Hépatite chronique virale C :**

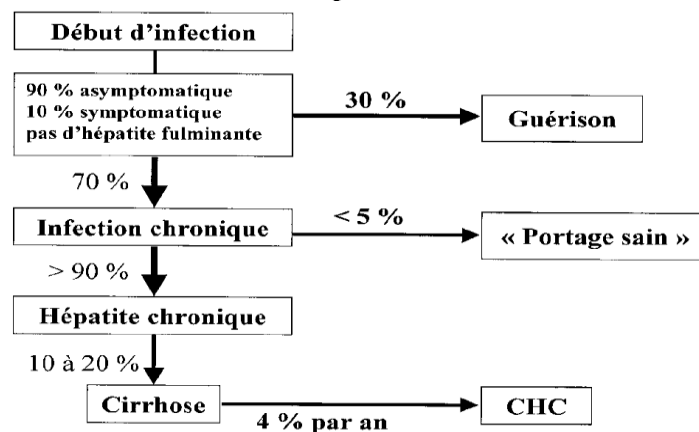
➤ **Epidémiologie :**

- Problème de santé publique, 170 millions de porteurs chroniques dans le monde avec une prévalence de 3% en Algérie
- Transmission du virus : le VHC existe principalement dans le sang, il peut donc être transmis par voie parentérale, par voie sexuelle (très faible), ou par voie verticale (périnatale)
- Temps d'incubation est de 15-90 jours

➤ **Virologie :**

- Le VHC est un virus à ARN simple brin appartenant à la famille des Flavivirus
- Il en existe 7 génotypes du VHC avec plusieurs sous types
- Les marqueurs du diagnostic virologiques :
 - /Ac anti VHC : mais ne différencie pas entre une infection actuelle et une infection guérie
 - /PCR du VHC : **certitude diagnostique** en mettant en évidence la présence de l'ARN du virus et le quantifier

➤ **Histoire naturelle de l'hépatite C:**



➤ **Diagnostic :**

- Souvent un diagnostic fortuit à l'occasion d'un dépistage systématique chez les donneurs de sang et chez des populations à risque (toxicomanie IV, patients transfusés, hémodialysée, homosexuels,...etc)
- Parfois un symptôme révélateur imposant la réalisation d'une sérologie virale : asthénie persistante, ictère, HPM, un syndrome d'HTP, ou une complication révélatrice (ascite, hémorragie digestive, CHC)
- Biologie : Ac anti VHC (+), taux d'ALAT parfois élevé
- Biologie moléculaire : quantification de l'ARN viral par PCR
- PBF : mise en évidence des lésions histologique spécifique et évaluation de la sévérité » de l'atteinte selon le Métavir
- Fibrotest et fibroscan : évaluation non invasive du degrés de fibrose hépatique

➤ **Traitement :**

-But : Eradiquer le VHC, stopper l'évolution vers la cirrhose et prévenir les complications

-Moyens thérapeutiques :

/Interferon pégylé + Ribavirine : taux d'éradication = 45%

/Trithérapie (Interferon pégylé + Ribavirine + télaprévir ou Bocéprévir) : taux d'éradication = 70%

/Antiviraux à action directe de nouvelle génération (Sofosbuvir + lédipasvir / Sofosbuvir + daclatasvir): taux d'éradication > 90 %

2- Les hépatites médicamenteuses :

-**Rares** < 2 % des hépatites chroniques

-Survienent généralement après administration médicamenteuse **prolongée ≥ 6 mois**

-02 principaux mécanismes :

/Action toxique directe

/ Action immuno-allergique

-Clinique : souvent insidieuse, c'est un diagnostic d'exclusion

-Biologie : syndrome de cytolyse (taux ALAT élevé)/ syndrome de cholestase (PAL, gammaGT, Bilirubine : élevés)/ Ac anti tissus (surtout anti noyaux) sont positifs

-Histologie : Hépatite chronique non spécifique avec parfois un infiltrat à PNE et présence de granulomes

-Principaux médicaments en cause : Aldomel, Isoniazide, Méthotrexate, Halotane, Sulfamides, Paracétamol, Acide salicylique, Oxyphenisatine, diclofénac, phénylbutazone, Amiodarone.

-Evolution : Régression lente des lésions après arrêt du traitement

3- Les hépatites auto-immunes :

-Plus fréquentes chez la femme

-Souvent associées à s'autres maladies auto-immunes : thyroïdite auto-immune, syndrome sec, polyarthrite rhumatoïde, diabète, maladie coeliaque, MICI.

-Clinique : asthénie, amaigrissement, ictère franc, parfois signes de cirrhose et de ses complications

-Biologie : /Cytolyse d'intensité variable (augmentation des ALAT et des ASAT)

/Parfois augmentation modérée des PAL, gammaGT et de la bilirubine

/Augmentation des gamma globuline (IgG > 1.5 fois la normale)

/Auto Ac positifs à un titre significatif

- **HAI type I** : Ac anti nucléaires, Ac anti muscle lisse , Ac anti SLA

- **HAI type II** : Ac anti LKM1, Ac anti LKM3, Ac anti LC1

-Histologie : infiltrat inflammatoire riche en plasmocyte et hépatocytes disposés en rosette, nécrose parcellaire +/- fibrose

-Traitement : corticoïdes et immunosuppresseur

4- La maladie de Wilson

-Maladie génétique autosomique récessive liée à une mutation du gène ATP7B situé sur le bras long du chromosome 13

-Elle entraîne une accumulation anormale du Cuivre dans le foie et dans plusieurs autres organes

-Survient souvent à l'enfance ou chez l'adulte jeune.

- Eléments du Diagnostic: /signes d'hépatopathie : ictère, asthénie, HPM, HTP
 - /troubles neurologiques.
 - /anneau cornéen de K. Fleicher
 - /néphropathie tubulaire.
 - /contexte familial.
- biologie: /Syndrome de cytolyse
 - /Anémie hémolytique
 - /ceruloplasmine basse.
 - /cuprurie élevée.
 - /cuprémie basse.
- Anapath: corps de Mallory + stéatose + dosage pondéral du Cu^{+++}
- TRT: D-penicillamine.

V- CONCLUSION

- L'hépatite chronique est définie par des lésions necrotico-inflammatoire hépatiques qui dure de plus de 06 mois
- Les étiologies sont multiples dominés par les causes virales qu'il faut savoir diagnostiquer et traiter à temps pour éviter l'évolution vers la cirrhose et ses complications